

Paralysie Faciale (VII) : Anatomie, Sémiologie et Pathologie

Le Guide d'Étude Exhaustif & L'Analyse Clinique Intégrale

Table des Matières :

1. Analyse des Tendances d'Examen (Pattern Analysis)

2. Définition et Distinction PFP vs PFC

3. Anatomie et Physiologie (VII et VII bis)

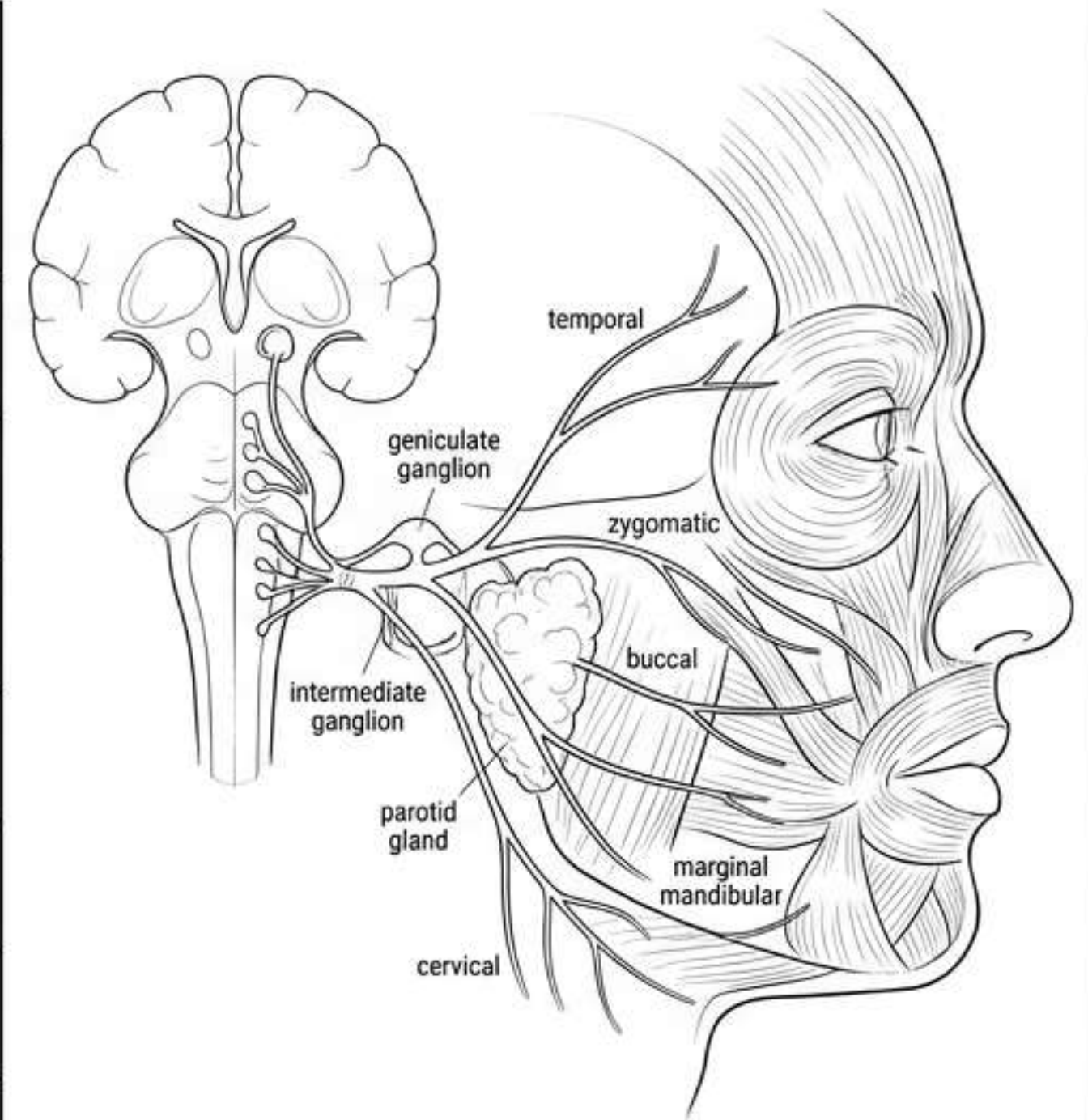
4. Étiopathogénie : Le Garrot Ischémique

5. Sémiologie Clinique et Topographique

6. Explorations Paracliniques (TDM/IRM/EMG)

7. Études Étiologiques (Bell, Infectieuses, Tumorales)

8. Protocole Thérapeutique et Séquelles



Nerf Facial (VII) - Cartographie Globale

Analyse des Tendances d'Examen & Stratégie

Décryptage des QCM passés et prédictions cliniques (**Intelligence Matrix**)

Sujets les plus répétés (Taux de récurrence très élevé) :

- **Sémiologie Différentielle** : La distinction absolue entre Paralysie Faciale Périphérique (PFP) et Centrale (PFC). **Le Signe de Charles Bell positif** [Ref: Q11, Q11_2023, Q11_2018, Q7] est l'axe central des QCM.
- **Anatomie Végétative** : **Le rôle du grand nerf pétreux superficiel et de la corde du tympan** [Ref: Q10, Q10_2023] tombe systématiquement.
- **Prise en Charge PFP Idiopathique** : L'urgence de **la corticothérapie précoce et la protection de la cornée** [Ref: Q9, Q31, Q3, Q5_2017].

Pièges Fréquents & Anomalies :

- **Le Piège Charles Bell** : **La PFC a un signe de Charles Bell négatif** [Ref: Q84, Q1_2018, Q1_2017]. L'associer à la PFC est l'erreur la plus ciblée.
- **Le Piège de l'Antibiothérapie** : Souvent proposée pour la paralysie de Bell, elle doit être **évitée au profit de la corticothérapie/antiviral** [Ref: Q9].

 **WARNING**

 Antibiothérapie

Prédictions pour le Prochain Examen (Confiance 95%) :

- **Les tests topographiques précis** (Test de Schirmer + Réflexe stapédien + Électrogustométrie) [Predicted - Matériel paraclinique hautement structuré dans le PDF, jamais testé récemment].
- **Le mécanisme ischémique de l'œdème** (le garrot ischémique) [Predicted - Le Professeur a lourdement insisté sur ce point physiopathologique dans l'enregistrement audio].

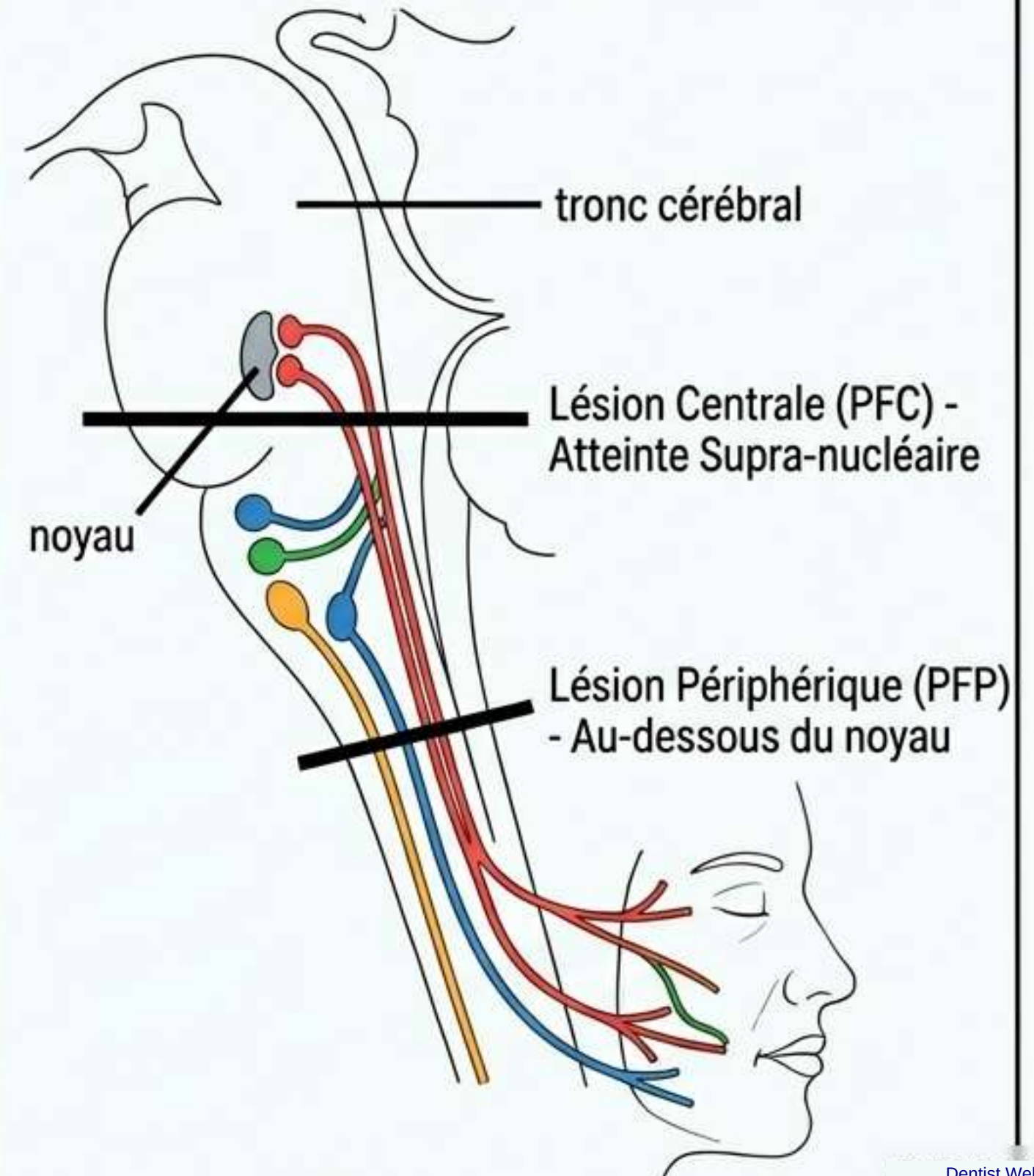
Définition de la Paralysie Faciale et Topographie Lésionnelle

L'atteinte de la 7ème paire crânienne (VII) - Mixte (Motrice, Sensitive, Sensorielle, Végétative)

Définition Stricte : Atteinte de la septième paire (VII) des nerfs crâniens réalisant une **paralysie de l'hémiface** (perte de tonicité et motricité des muscles peauciers de la face et du cou).

La Règle d'Or Topographique (Le Diagnostic de Base) :

- **Paralysie Périphérique (PFP) :** La lésion affecte le deutoneurone en aval du noyau du tronc cérébral (où il naît), jusqu'aux muscles (où il se connecte), soit au-dessus du noyau [Ref: Q83, Q7_2017].
- **Paralysie Centrale (PFC) :** Différenciée par deux faits cliniques absolus :
 - Dans la PFP, le déficit moteur est homogène (territoire supérieur ET inférieur de la face). Dans la PFC, il prédomine sur le territoire inférieur [Predicted - Point de bascule clinique majeur répété en audio].
 - Il n'y a pas de dissociation automatico-volontaire dans la PFP, contrairement à la PFC [Ref: Q84, Q1_2018, Q1_2017].



Architecture Anatomique : Le VII et le VII bis

Le nerf de la mimique, des émotions non verbales, et des sécrétions

Le nerf facial est formé de deux racines distinctes :

1. La Racine Motrice (Le VII proprement dit) :

- La racine la plus volumineuse.
- Innervation : Tous les muscles peauciers de la face et du cou.

2. La Racine Sensitive, Sensorielle et Sécrétoire (Le VII bis) :

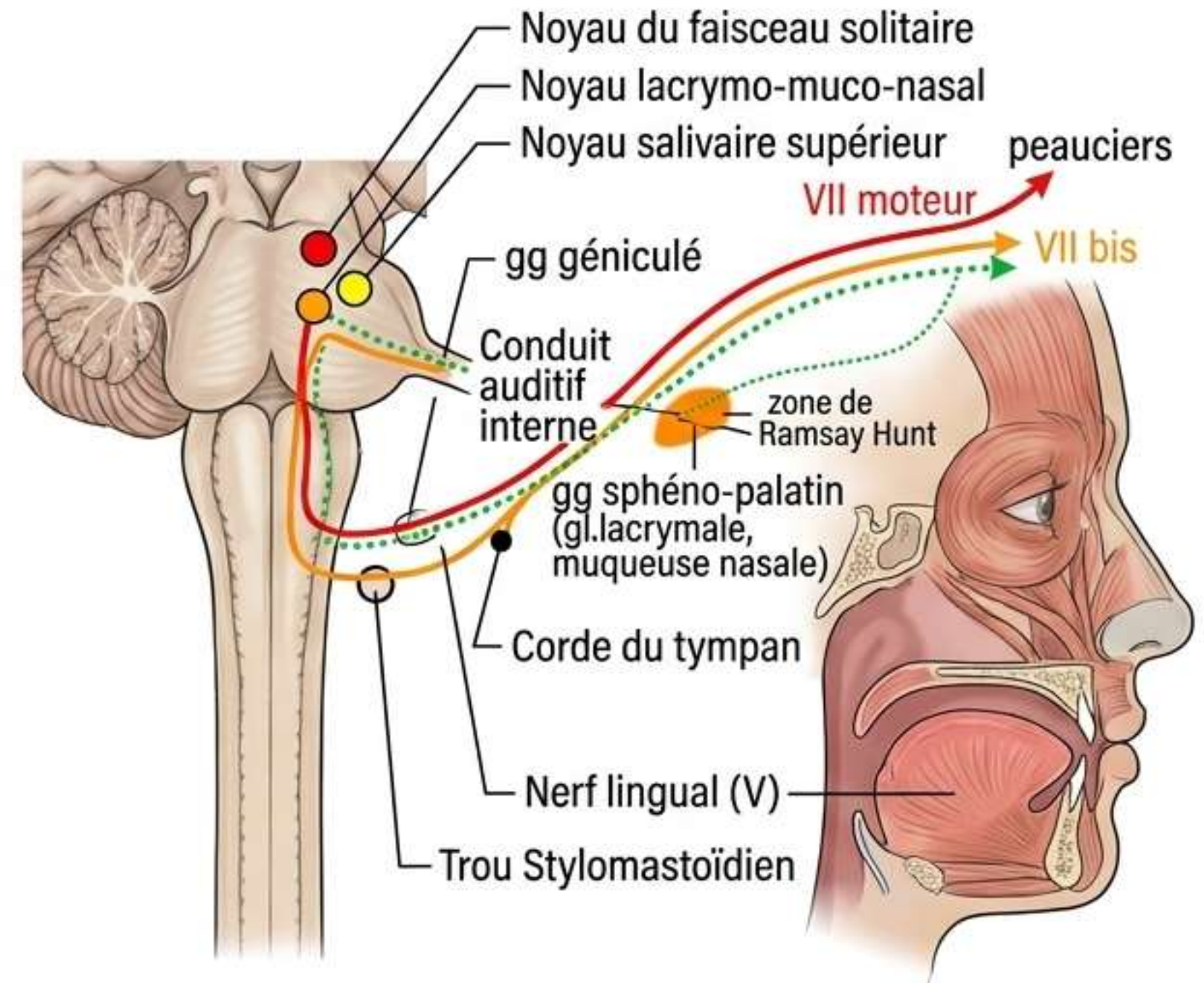
- Aussi appelée l'Intermédiaire de Wrisberg.

'Constituée de fibres végétatives parasympathiques et de fibres sensibles'.

[Ref: Q99]

'Son trajet traverse l'espace ponto-cérébelleux, le conduit auditif interne (CAI), puis les 3 portions du rocher (labyrinthique, tympanique, mastoïdienne)'.

[Predicted - Segmentation audio clé pour la localisation des lésions].



Anatomie du nerf facial

Cartographie Physiologique du Nerf Facial

Répartition fonctionnelle exacte des 4 composantes du nerf mixte

■ Fonction Motrice (Rouge) :

- Ventre postérieur du muscle digastrique.
- Muscle stylohyoïdien.
- Muscle de l'étrier (voie du réflexe stapédien).
- Muscles de la mimique/expression (paupières, sourcils, nez, lèvres, pavillon oreille).
- Muscle peaucier du cou (platysma).

■ Fonction Sensitive (Bleu) :

- Zone de Ramsay-Hunt : Tragus, conque, anthélix, méat auditif externe, paroi postérieure du CAE, face externe de la moitié postérieure du tympan.

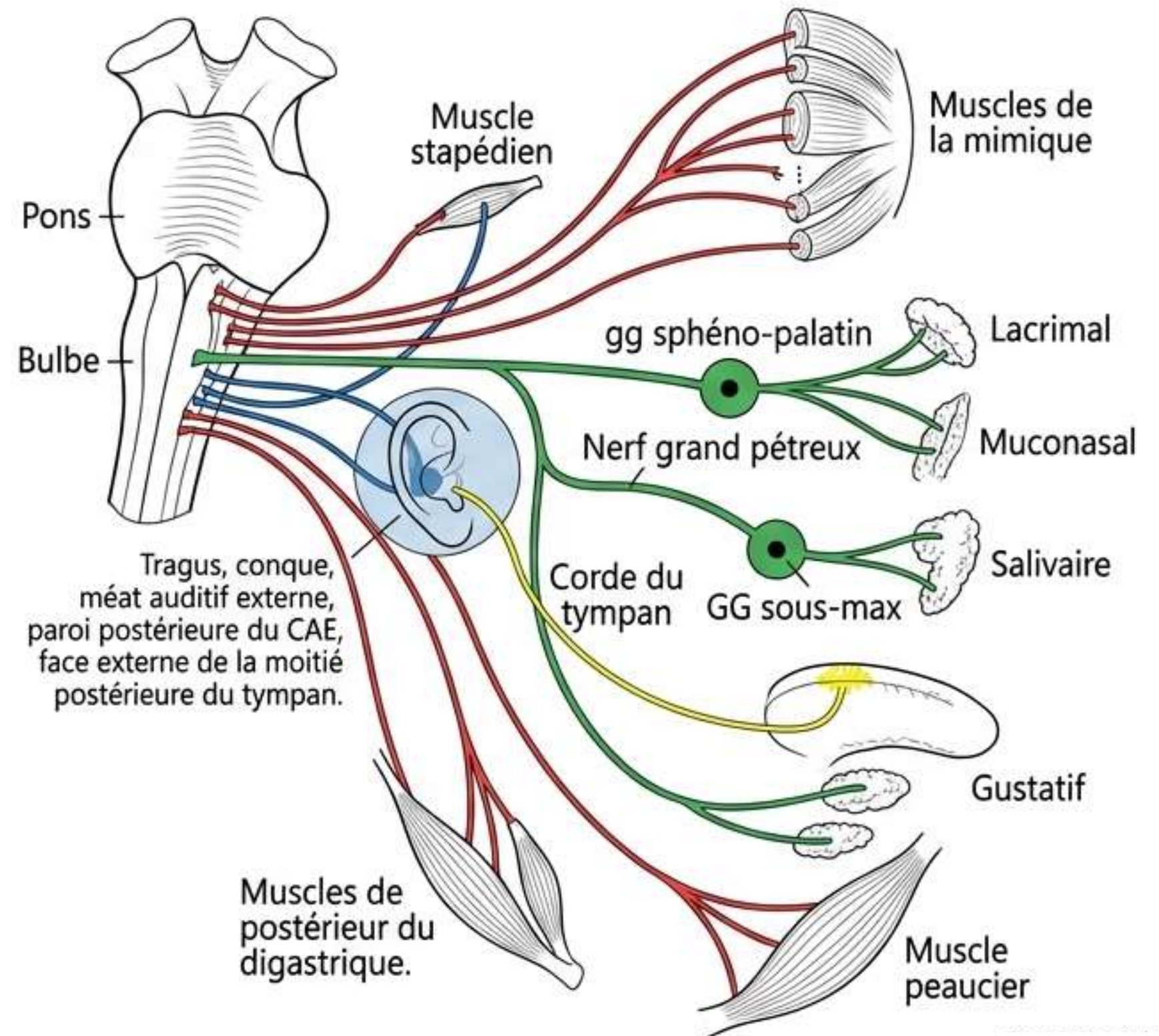
■ Fonction Sensorielle (Jaune) :

- Corde du tympan : Sensibilité gustative des 2/3 antérieurs de l'hémilangue homolatérale.

■ Fonction Végétative Parasymphatique (Vert) :

Assurée par le grand nerf pétreux superficiel (glandes lacrymales / muqueuse fosses nasales) et la corde du tympan (glandes sous-maxillaires / sublinguales).

[Ref: Q10, Q10_2023].



Étiopathogénie : Le Concept du Garrot Ischémique

Pourquoi le nerf facial est-il particulièrement vulnérable ?

Les Mécanismes de Lésion (Causes) :

- **Virales** (les plus fréquentes).
- **Mécaniques traumatiques** ou chirurgicales.
- Compression par tumeurs bénignes (cholestéatome) ou malignes.

La Pathogénie Fondamentale (L'Enfermement) :

- **Vulnérabilité anatomique** : Relatif confinement du VII dans le canal du facial (conduit osseux inextensible, ou canal de Fallope), ce qui le fragilise.
- La **Cascade Ischémique** :

Quel qu'en soit l'origine (virale, traumatique), le nerf subit un œdème. Enfermé dans son canal inextensible, cet œdème comprime le nerf sur lui-même

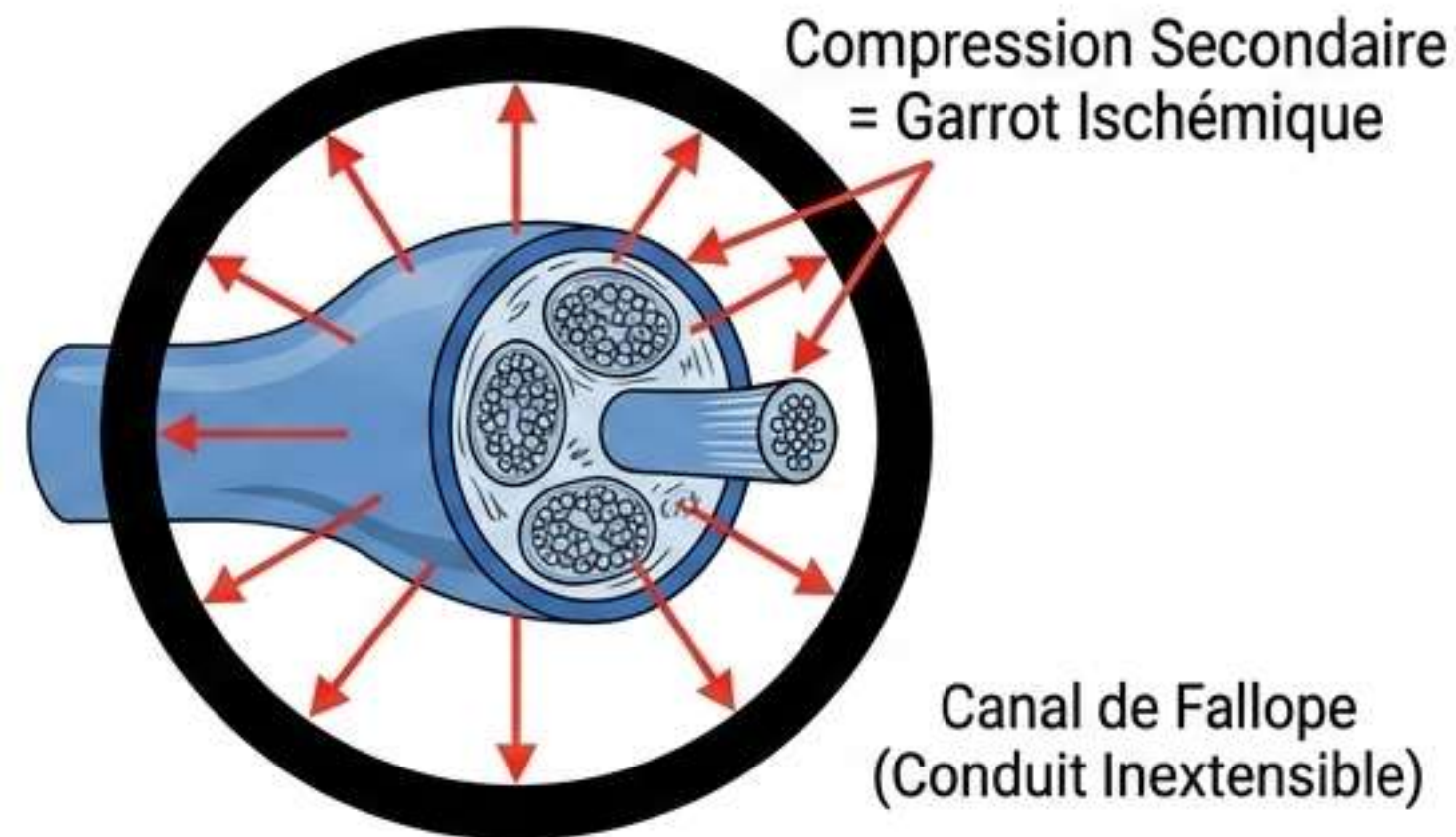
[Predicted - Le professeur insiste sur la réaction inflammatoire de l'organisme comme vraie cause des dégâts].

- Ceci **induit un garrot ischémique**, inducteur de lésions nerveuses secondaires (pouvant apparaître avec un délai).

Phase 1: Agression (Virus, Trauma)



Phase 2: Œdème du Nerf Facial



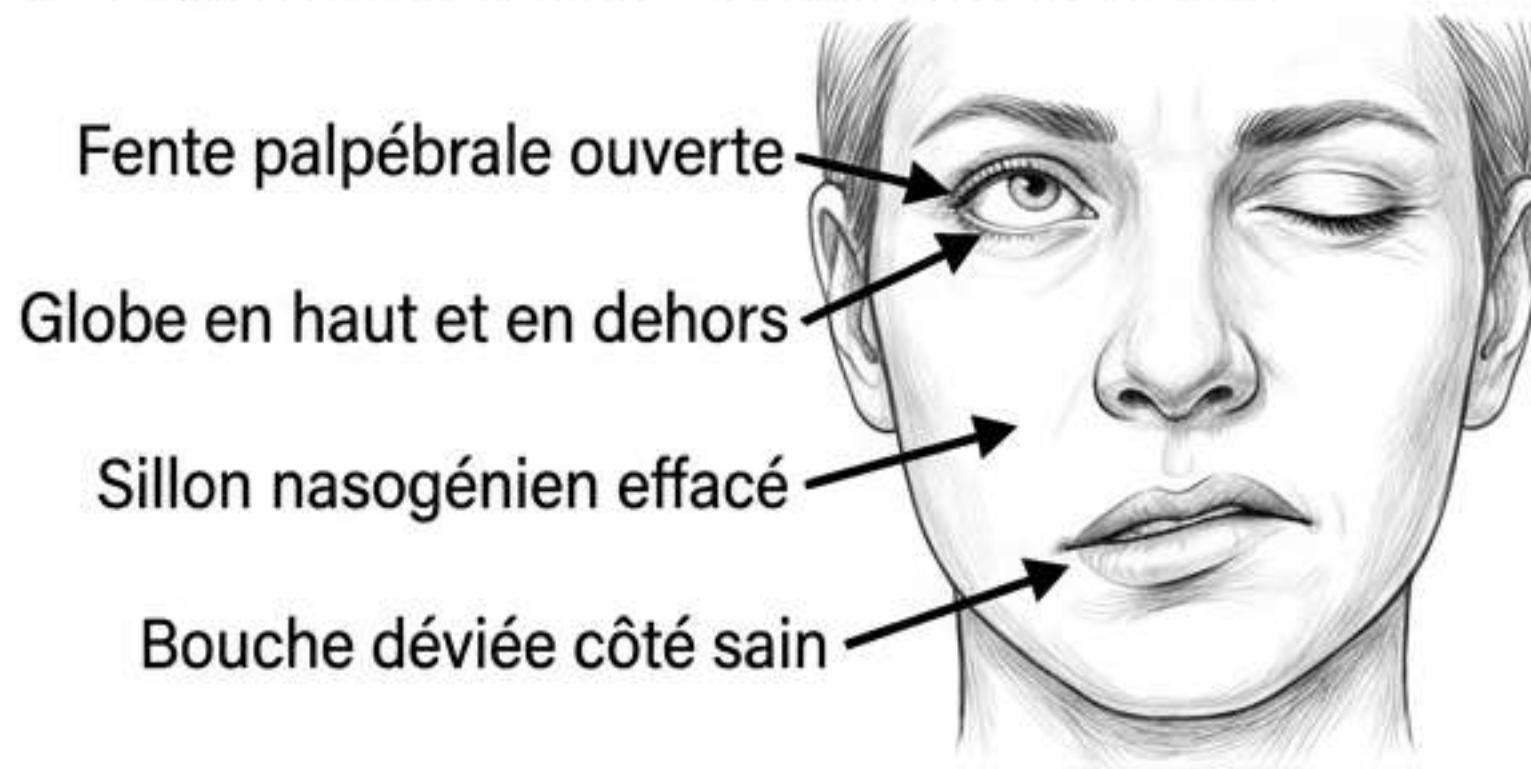
Sémiologie de la Paralysie Faciale Périphérique (PFP)

L'atteinte unilatérale et totale (Étages supérieur et inférieur)

Règle Clinique Absolue : L'atteinte est unilatérale et totale. Tous les muscles de la face sont paralysés (supérieur et inférieur) [Ref: Q11, Q11_2023, Q11_2018]

Sémiologie au Repos :

- Asymétrie frappante.
- Rides du front et pli nasogénien sont effacés.
- Commissure labiale est abaissée du côté paralysé.
- Bouche déviée du côté sain (attraction).
- Fente palpébrale largement ouverte et clignement aboli.



Sémiologie lors du Mouvement (Mimique) :

- La paralysie s'accentue (impossibilité de sourire).
- **Signe de Charles Bell positif** : La fermeture des paupières est impossible du côté paralysé, tandis que le globe oculaire se déplace en haut et en dehors [Ref: Q11, Q7]
- **Réflexe cornéen** aboli (sensibilité cornéenne normale).
- Signes associés possibles : **Hyperacousie, agéusie** (2/3 ant. langue).

Diagnostic Différentiel : La Paralyse Centrale (PFC)

L'atteinte supra-nucléaire (au-dessus du noyau)

La PFC est souvent causée par des atteintes vasculaires ou tumorales. Elle se distingue radicalement de la PFP.

	PFC (Centrale)	PFP (Périphérique)
Territoire Moteur Touché	Prédomine très nettement sur la partie inférieure du visage [Ref: Q84, Q1_2018, Q1_2017]. (Explication : projection bilatérale du 1er neurone operculaire sur le noyau supérieur). Discrète atteinte supérieure possible.	Homogène (Supérieur + Inférieur).
Signe de Charles Bell	 Signe de Charles Bell NÉGATIF [Ref: Q84, Q1_2017].	 Positif.
Mouvements	Dissociation automatico-volontaire [Ref: Q84, Q1_2018, Q1_2017]. Asymétrie plus marquée lors des mouvements sur consigne que spontanés (rires). Impossibilité de siffler/dégonfler joues.	Pas de dissociation.
Signes Associés	Presque toujours associée à une hémiplegie/hémi-parésie homolatérale.	Atteintes cochléo-vestibulaires ou gustatives.

Explorations Topographiques : Situer la Lésion

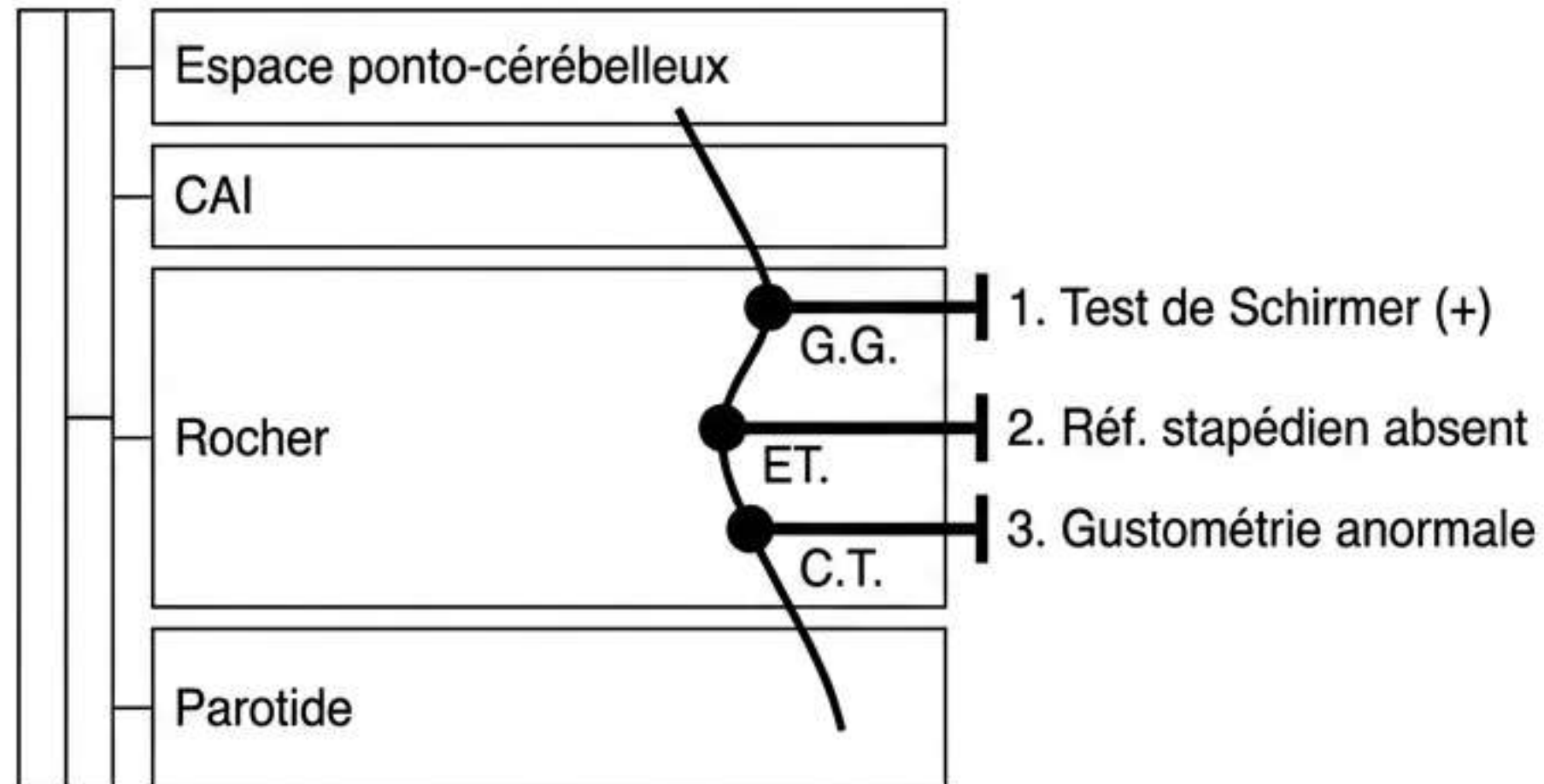
Tests cliniques et paracliniques pour cartographier le déficit

1. Examen Clinique du Visage : Diagnostic facile (sauf nourrisson). Hémiface lisse/flasque. Côté sain : attraction nez/bouche. Côté paralysé : abaissement paupière inférieure, élargissement fente, Charles Bell.

2. Examens Paracliniques Topographiques : Ces tests simples situent la lésion sur le trajet du nerf facial :

[Predicted - L'étagement des lésions est visuellement très structuré dans le cours].

- Atteinte au niveau ou en amont du **Ganglion Géniculé** (Nerfs pétreux) : Test de Schirmer positif (déficit de sécrétion lacrymale du côté paralysé comparé à l'autre).
- Atteinte au niveau **Mastoïdien** : Test de Schirmer normal, MÊME électrogustométrie anormale, ET absence de réflexes stapédiens.
- Atteinte au foramen stylomastoïdien ou en aval : Test de Schirmer normal, gustométrie normale, ET réflexes stapédiens présents.

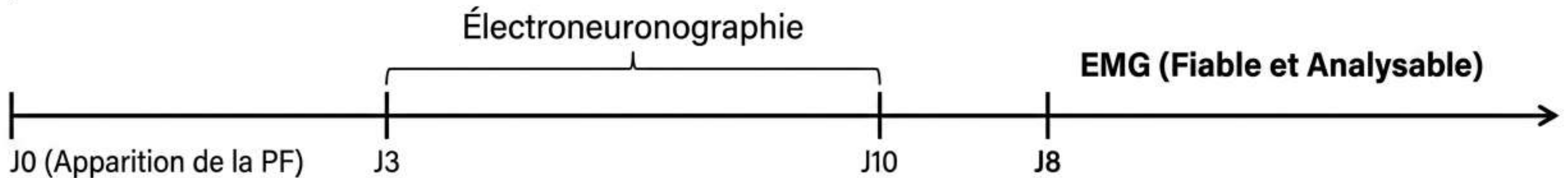


Explorations Électrophysiologiques et Imagerie

Évaluer la gravité, la régénération, et la cause profonde

Explorations Électrophysiologiques :

- **Électroneuronographie** : Test de stimulation-détection. Simple et rentable.
À réaliser dans les dix premiers jours (J3 – J10) [Predicted - La fenêtre temporelle est cruciale cliniquement].
- **Électromyographie (EMG)** : Détection et stimulodétection. Plus fiable et reproductible.
Analysable seulement dès J8 [Predicted].



Imagerie Médicale (TDM et/ou IRM) :

L'imagerie n'est pas systématique pour une PFP typique (a frigore). Elle est strictement indiquée dans les contextes suivants :



- ☐ Formes progressives.
- ☐ Formes récidivantes.
- ☐ Formes graves non régressives.
- ☐ Formes syndromiques : surdité, vertiges, ou autres atteintes des nerfs crâniens associées.

Étude Clinique I : Paralysie Idiopathique (De Bell)

La PFP 'a frigore' - Diagnostic d'élimination et d'urgence

Définition et Installation : C'est la cause la plus fréquente des paralysies faciales périphériques [Ref: Q4, Q29].

Mode d'apparition : Installation brutale sans cause évidente, souvent le matin au réveil ou après une exposition au froid [Ref: Q4].

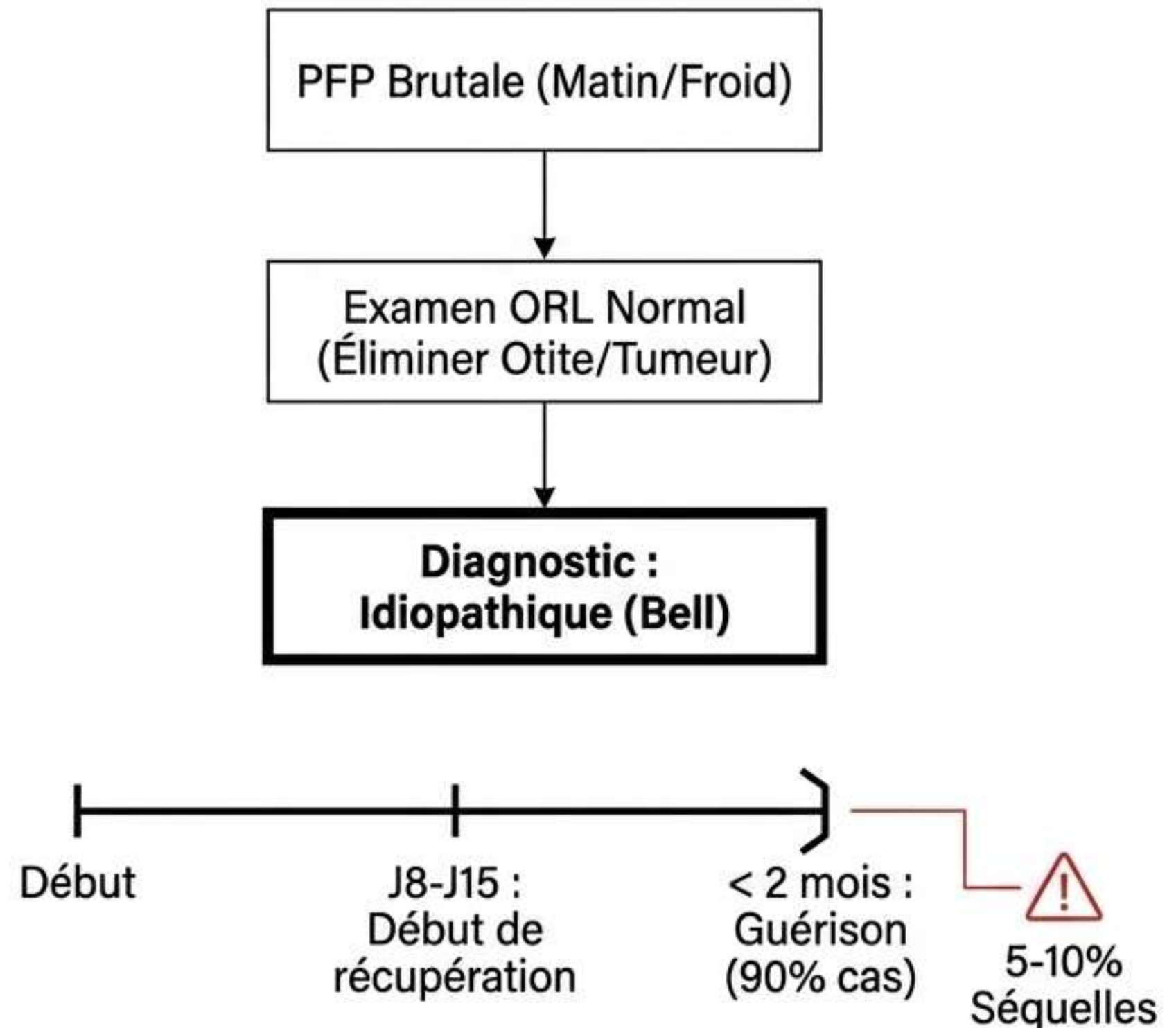
Isolée, parfois précédée de douleurs mastoïdiennes et accompagnée de troubles du goût.

Pathogénie et Précautions :

- Étiologie d'une réactivation virale (HSV1 le plus souvent) aujourd'hui démontrée.
- Règle d'or : Toujours s'assurer par microscope, tympanométrie et réflexes stapédiens qu'il n'y a pas de cause otique (otite, cholestéatome) ou tumorale.

Évolution Naturelle :

- Favorable dans la grande majorité (surtout si paralysie incomplète).



Protocole Thérapeutique de la Paralysie de Bell

L'urgence de la levée de l'œdème (Corticothérapie et Protection Oculaire)

Le traitement médical doit être précoce (72 premières heures) pour augmenter les chances de récupération.

L'antibiothérapie est inutile et doit être évitée [Ref: Q9].

1. Corticothérapie Orale (Le Pilier) :

Prescription de 1 mg/kg par jour pendant 10 jours pleins [Ref: Q3, Q31].

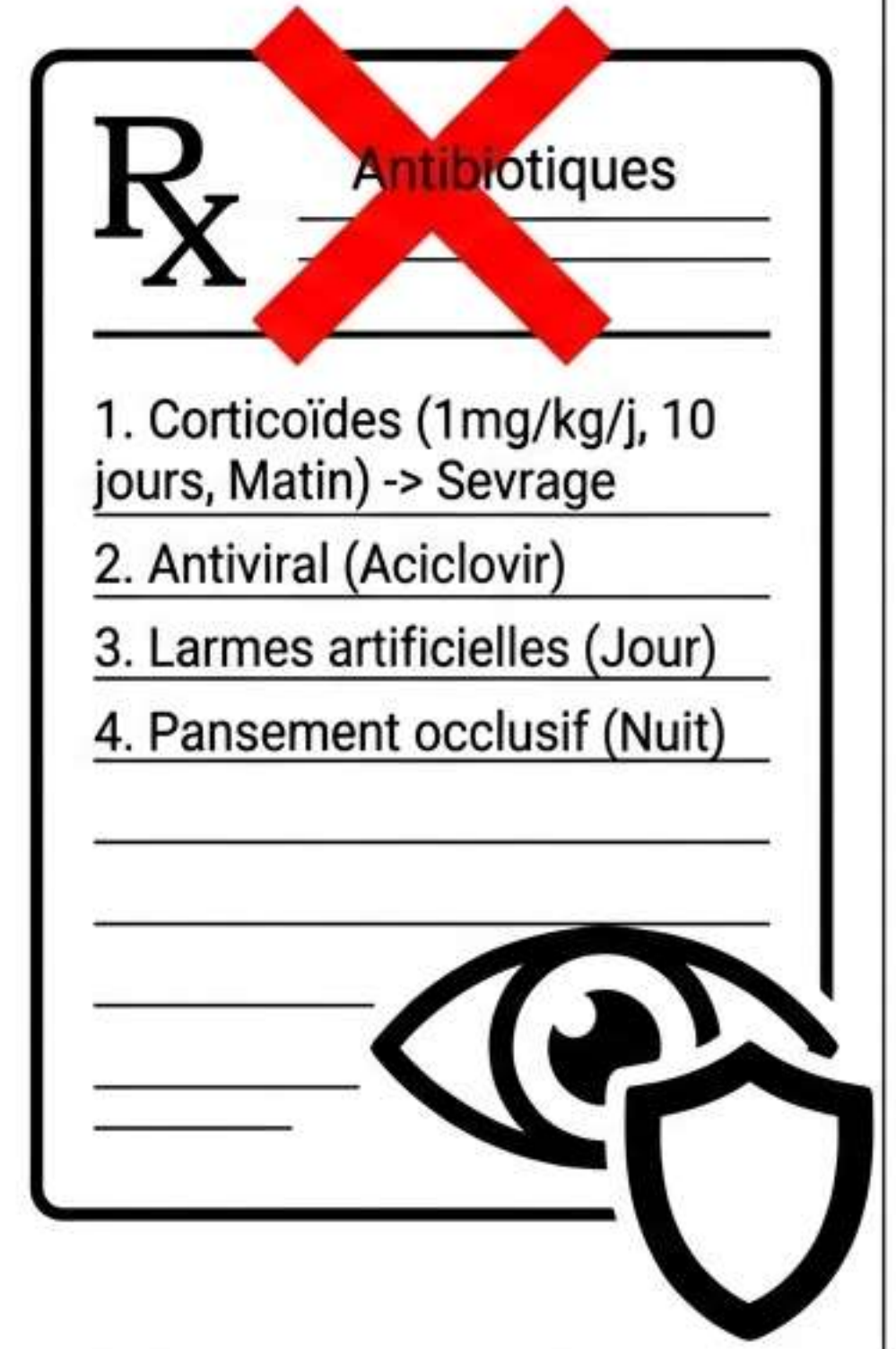
Protocole Audio : Prise le matin (respect cycle du cortisol), avec protecteur gastrique. Décroissance progressive (sevrage) sur 4-5 jours après les 10 jours [Predicted - L'application pratique détaillée par le prof].

2. Protection Oculaire (Indispensable) :

Prévention vitale des kératites par larmes artificielles (jour) et pansement occlusif (nuit) [Ref: Q5_2017, Q31].

3. Traitements Associés :

- **Antiviral** : Associé à la corticothérapie (ex: aciclovir).
- **Rééducation cervico-faciale** : Pour les muscles de la mimique.



Étude Clinique II : Paralysies Infectieuses

VZV (Zona), Maladie de Lyme, VIH et Affections Otogènes

VI.02.01. Zona Auriculaire : Résurgence du VZV (virus varicelle-zona) au niveau du ganglion géniculé [Ref: Q2, Q29].

- Clinique : Zone de Ramsay Hunt, syndrome de Sicard.
Éruption vésiculeuse (précédant ou suivant la PFP). Parfois surdité et vertiges (Atteinte du VIII = mauvais pronostic).
Traitement antiviral + corticoïdes.

VI.02.02. Maladie de Lyme :

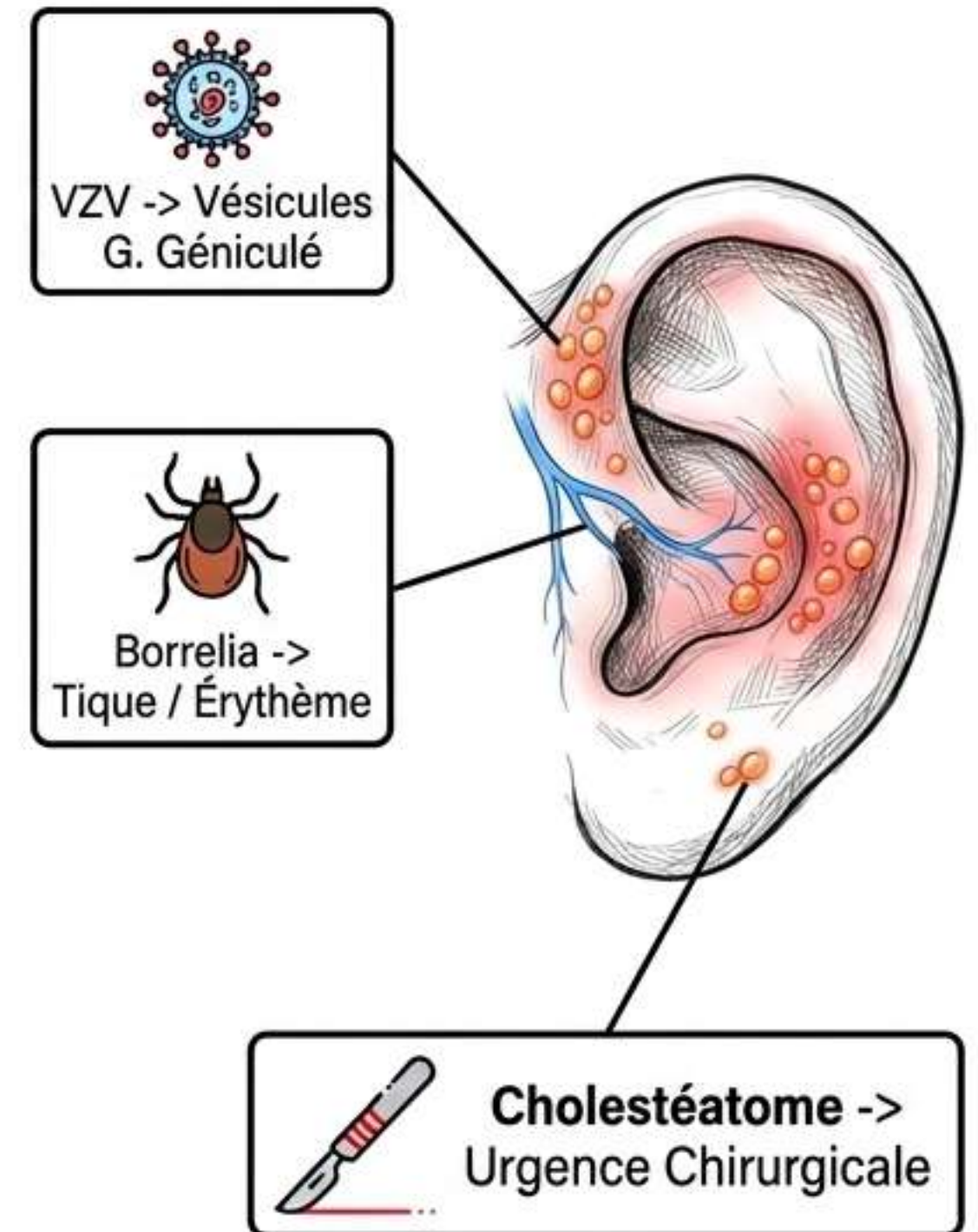
- Spirochétose (*Borrelia burgdorferi*) -> PF secondaire (méningoradiculite).
- Notion de morsure de tique / érythème migrant.
Macrolides, cyclines ou β -lactamines.

VI.02.03. Infection à VIH :

- Peut révéler la maladie. Souvent associée à une infiltration parotidienne (évoquant sarcoïdose).

VI.02.04. Paralysies Faciales Otogènes :

- Complique l'otite moyenne aiguë (régresse avec traitement).
Une PFP compliquant une otite moyenne chronique (cholestéatomateuse) impose une intervention otologique d'urgence
[Predicted - Le concept d'urgence chirurgicale otologique est majeur].
Sans cholestéatome = chercher tuberculose.



Étude Clinique III : Traumatismes, Tumeurs & Inflammations

Des fractures du rocher aux syndromes systémiques

VI.03. Traumatiques & iatrogènes :

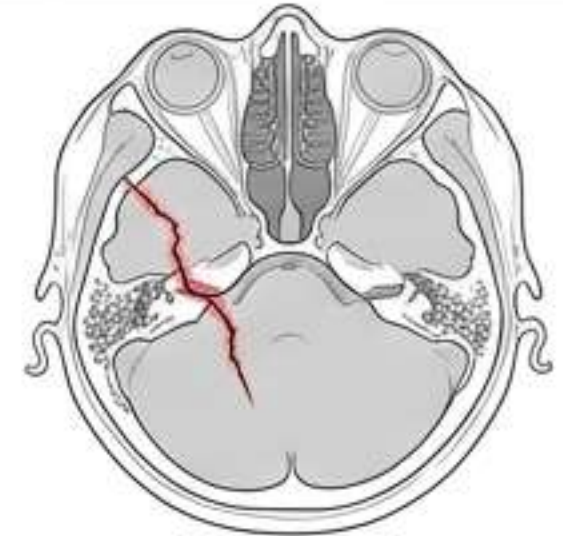
- **Fractures du rocher** : PFP (brutale) avec otorragie et signes cochléo-vestibulaires (seul signe d'une fracture crânienne).
- **Plaies parotidiennes** : Impose réparation chirurgicale immédiate.
- **iatrogènes** : Chirurgie du schwannome, chirurgie otologique, chirurgie parotidienne.

VI.04. Tumoraux :

Installation progressive. Tumeurs parotidiennes, angle pontocérébelleux (neurinome, méningiome), rocher (paragangliome), tronc cérébral [Ref: Q29, Q8].

VI.05. Congénitales & Inflammatoires :

- **Néonatales** : Syndrome de Moebius (diplégie faciale + atteinte oculomotrice), agénésie du VII, compression forceps.
- **Inflammatoires** :
 - Sarcoidose : Infiltration VII, parotidite, iridocyclite (Syndrome d'Heerfordt).
 - Melkerson Rosenthal : PFP récidivante, œdème des lèvres, langue plicaturée (scrotale).



Fracture du rocher traversant le CAI



Cancer de la parotide responsable d'une paralysie



Asymétrie évidente au cri

Séquelles Évolutives, Réhabilitation et Synthèse

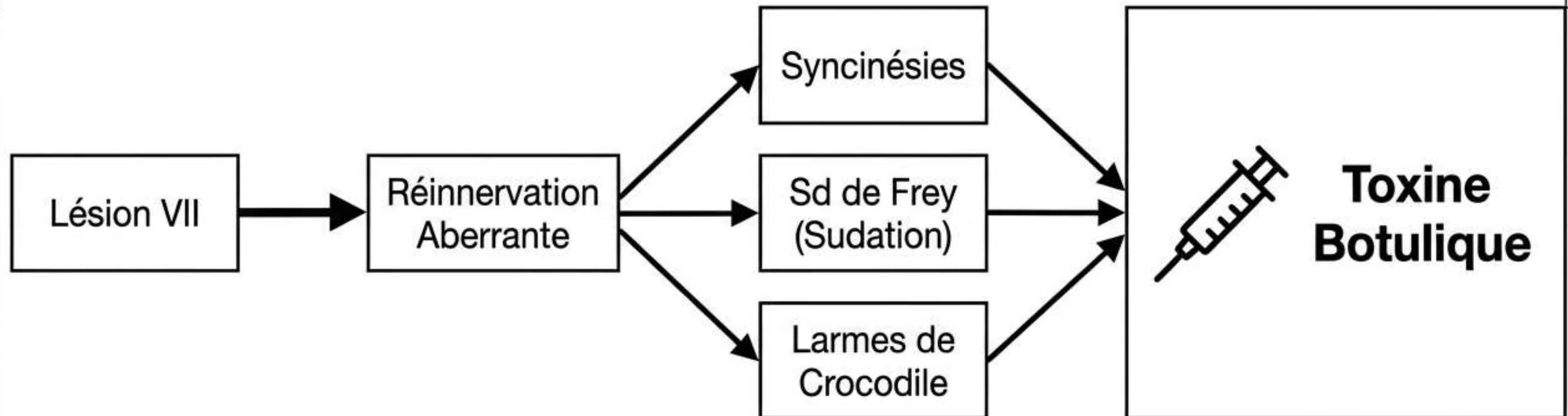
Gestion de la réinnervation aberrante et Cartographie Finale

VII.01. Séquelles (5 à 10% des cas avec récupération incomplète) :

- Asymétrie faciale persistante, spasmes.
- Syncinésies : Gonflement des joues ferme l'œil (si PFP initiale sévère de grade IV).
- Syndrome de Frey : Sudation excessive de la région parotidienne à la mastication.
- Larmes de crocodile : Épiphora (larmoiements) lors de la salivation/repas.

VII.02. Réhabilitation :

- Injection de toxine botulique (symétrise le faciès et bloque Frey/Crocodile/Spasmes). [Predicted - Mentionné en détail comme solution répétitive dans l'audio].
- Chirurgie : Anastomoses nerveuses (hypoglosso-faciale), Myoplastie d'allongement du temporal.



HAUTE SYNTHÈSE (Mind Map)

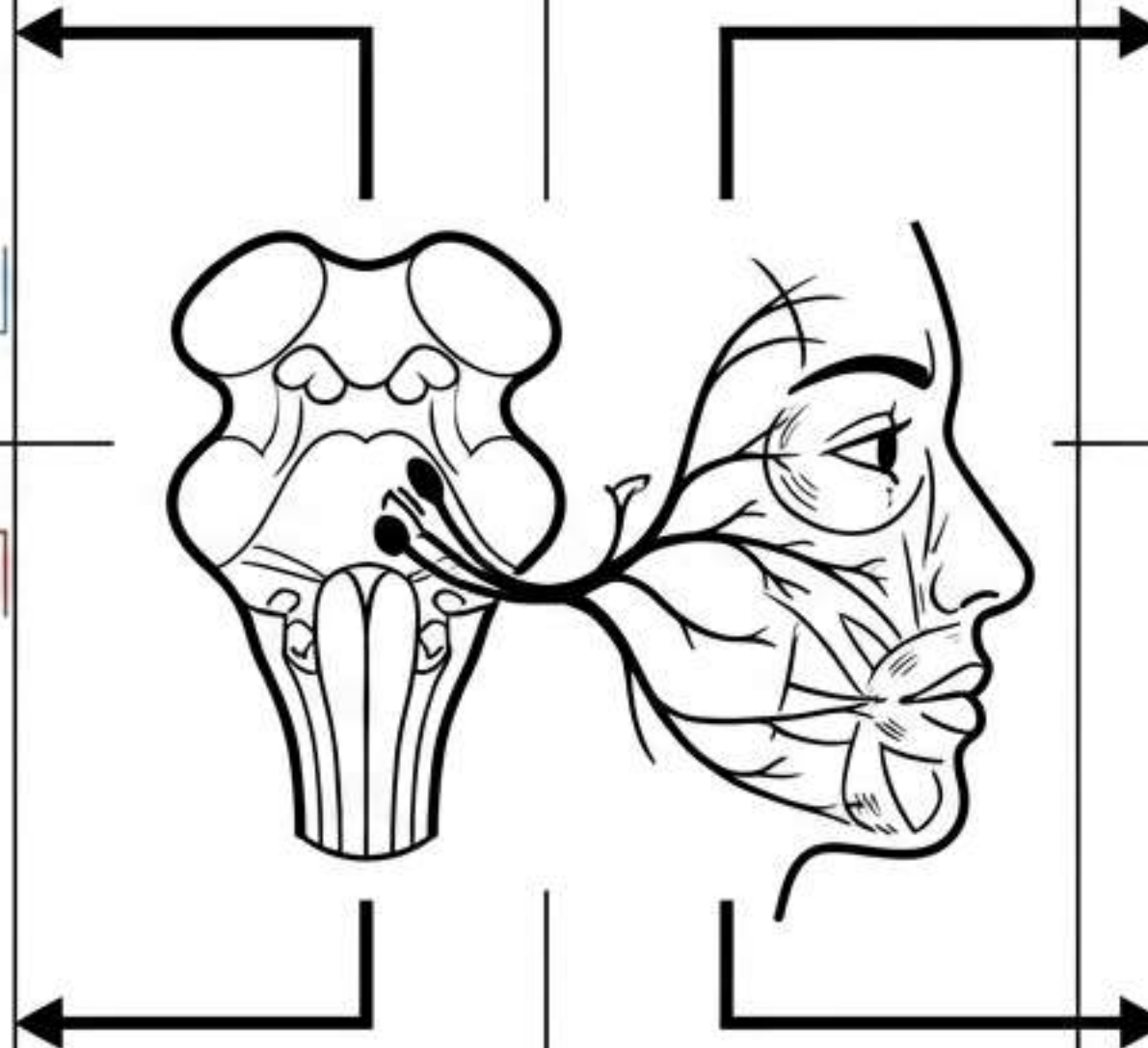
Cartographie Globale : Paralysie Faciale (VII)

1. ANATOMIE & RÔLE

- **VII Moteur** : Muscles Peauciers / Étrier
- **VII bis** : **Sensitif** (Ramsay Hunt) / **Sensoriel** (Corde Tympan 2/3 langue) / **Végétatif** (Glandes Lacrymales & Salivaires)

2. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL (CRITIQUE)

- **PFP (Périphérique)** : Sous le noyau, Face Sup + Inf,
Charles Bell (+)
en contraste fort.
- **PFC (Centrale)** : Sus-nucléaire, Face Inférieure dominante,
Charles Bell (-)
Dissociation automatico-volontaire.



3. ÉTIOLOGIES

- **Brutale** : Idiopathique (A frigore/Bell), Virale (Zona VZV), Traumatique.
- **Progressive** : Tumorale (Parotide, Rocher, Tronc).
- **Inflammatoire** : Sarcoïdose, Melkerson Rosenthal.

4. PRISE EN CHARGE (BELL)

- **OUI** : Corticothérapie précoce (1mg/kg/j) + Antiviral + Protection cornéenne stricte.
- **NON** : Antibiothérapie.